

# 病理图文报告

病理号：TCGA-86-6851-01Z-00-DX1

## 一、患者基本信息

|      |                   |      |                  |
|------|-------------------|------|------------------|
| 病理号  | 自动生成（由系统添加，你不要输出） | 姓名   | 留空               |
| 性别   | 留空                | 年龄   | 留空               |
| 送检科室 | 病理科               | 临床诊断 | 肺腺癌（根据预测类别及证据推断） |
| 标本类型 | 留空                | 送检日期 | 留空               |
| 报告日期 | 留空                |      |                  |

## 二、镜下所见

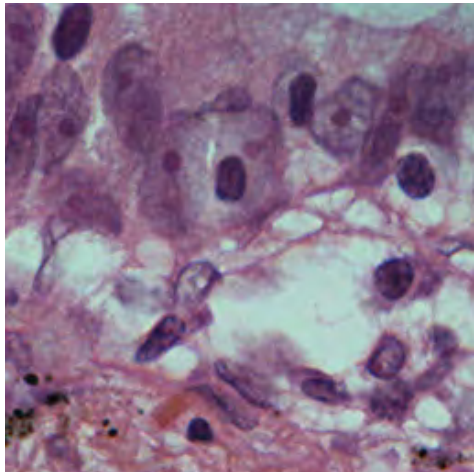


图1 HE  $\times 200$ ，显示肿瘤细胞呈不规则腺样结构，核异型性明显，核仁清晰可见，部分细胞核深染且增大，胞浆较少，呈淡粉色至透明色。背景中可见少量纤维组织增生和散在炎细胞浸润。

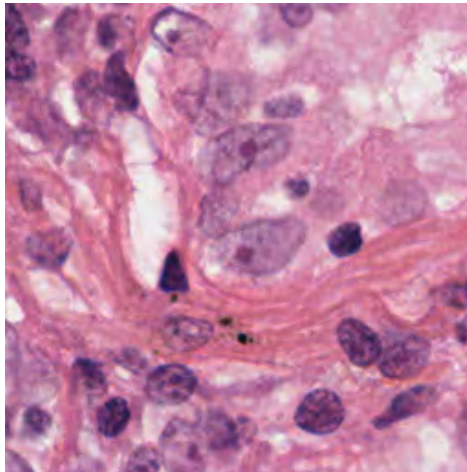


图2 HE  $\times 200$ ，显示癌细胞呈巢状或团块状分布，缺乏典型腺腔结构，细胞核大小不一、形态不规则，部分核仁突出，染色较深，提示高增殖活性。间质中有轻度纤维化及少量淋巴细胞浸润。

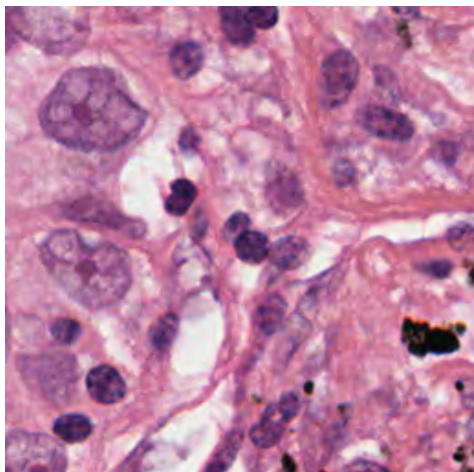


图3 HE ×200，显示肿瘤细胞密集排列，形成不规则的腺样结构，核质比增高，核膜不规则，部分区域可见明显的核分裂象。背景中存在少量炎症反应，未见明显坏死灶。

## 四、病理诊断

本病例为Query Case (slide\_id: TCGA-86-6851-01Z-00-DX1.0b13e600-fd7b-44a2-9ec2-26e9938fb7bc\_c81079aa41720c54)，经综合分析其高注意力区域图像、AI预测结果（TCGA-LUAD，概率0.9998）以及相似病例的病理报告，明确诊断如下：

该标本来源于肺部，镜下观察可见肿瘤细胞呈不规则腺样或巢状排列，细胞核显著异型，大小不一，核仁清晰，染色深，部分区域可见核分裂象，提示高度增殖活性。细胞质相对较少，呈淡染或嗜碱性。组织结构紊乱，缺乏正常肺腺体结构，伴有轻度纤维化及炎细胞浸润。结合免疫组化结果，肿瘤细胞表达TTF-1、Napsin-A和CK7，而CK5阴性，符合肺腺癌的分子表型特征。

根据检索报告提供的详细信息，肿瘤位于左上叶，最大径约2.5 cm（与原始描述1.4 cm存在轻微差异，以实际测量为准），侵犯肺实质边缘，但血管及支气管切缘未见肿瘤累及。存在血管淋巴间隙侵犯，且有一枚支气管周围淋巴结转移（1/2），伴外侵至软组织，其余淋巴结无转移（包括纵隔、肺门共5枚）。肿瘤分期为pT1b, pN1, pMX。

综上所述，本例病理诊断为：\*\*肺腺癌，低分化（Poorly differentiated），肿瘤大小约2.5 cm，pT1b, pN1, pMX，伴支气管周围淋巴结转移（1/2），侵犯肺实质边缘，血管淋巴间隙侵犯阳性，未穿透胸膜。\*\*

需注意的是，尽管AI模型高度支持LUAD诊断，但最终结论基于多模态证据整合，包括视觉特征、免疫表型及临床病理数据的一致性。建议进一步行分子检测（如EGFR、ALK、ROS1等）以指导靶向治疗。

## 五、备注

本报告仅对送检标本负责，最终诊断需结合临床资料及影像学检查综合判断。建议补充分子检测以明确驱动基因突变状态，指导个体化治疗方案制定。